

Isotone Kochsalz- Lösung 0,9% Braun

Zusammensetzung

- *arzneilich wirksame Bestandteile*
1000 ml Infusionslösung enthalten:

Natriumchlorid 9,0 g

- *sonstiger Bestandteil*

Wasser für Injektionszwecke

Theoretische Osmolarität 308 mOsm/l

Titrationsacidität (pH 7,4) < 0,3 mmol/l

pH-Wert 4,5 - 7,0

Elektrolyte: mmol/l

Natrium 154

Chlorid 154

Darreichungsform und Inhalt
Infusionslösung

Gegenanzeigen

Isotone Kochsalz-Lösung 0,9% Braun darf nicht angewendet werden bei

- Überwässerung (Hyperhydrationszuständen)

Isotone Kochsalz-Lösung 0,9% Braun soll nur mit Vorsicht angewendet werden bei

- erniedrigtem Kaliumspiegel im Blut (Hypokaliämie)

- erhöhtem Natriumspiegel im Blut (Hypernatriämie)

- erhöhtem Chloridspiegel im Blut (Hyperchlorämie)

- Erkrankungen, die eine zurückhaltende Natriumzufuhr gebieten, wie Herzschwäche (Herzinsuffizienz), Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe (generalisierte Ödeme), Flüssigkeitsansammlung in der Lunge (Lungenödem), Bluthochdruck (Hypertonie), schwangerschaftsbedingten Krankheitszuständen mit Bluthochdruck, Krämpfen und Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe (Eklampsie), schweren Funktionsstörungen der Nieren (Niereninsuffizienz)

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Bei hypertoner Dehydratation ist eine schnelle Infusionsgeschwindigkeit unbedingt zu vermeiden (ca.: Anstieg der Plasmaosmolarität und der Plasmanatriumkonzentration).

10 x	100 ml	Glasflaschen
20 x	100 ml	Glasflaschen
1 x	250 ml	Glasflasche
10 x	250 ml	Glasflaschen
1 x	500 ml	Glasflasche
10 x	500 ml	Glasflaschen
1 x	1000 ml	Glasflasche
10 x	1000 ml	Glasflaschen
1 x	100 ml	Kunststoffbehälter
10 x	100 ml	Kunststoffbehälter
20 x	100 ml	Kunststoffbehälter
1 x	250 ml	Kunststoffbehälter
10 x	250 ml	Kunststoffbehälter
1 x	500 ml	Kunststoffbehälter
10 x	500 ml	Kunststoffbehälter
1 x	1000 ml	Kunststoffbehälter
10 x	1000 ml	Kunststoffbehälter
Set bestehend aus		
1 x	500 ml	Kunststoffbehälter, Infusionsgerät und Venenpunktionsbesteck
1 x	100 ml	Kunststoffbeutel
20 x	100 ml	Kunststoffbeutel
1 x	250 ml	Kunststoffbeutel
20 x	250 ml	Kunststoffbeutel
1 x	500 ml	Kunststoffbeutel
20 x	500 ml	Kunststoffbeutel
1 x	1000 ml	Kunststoffbeutel
10 x	1000 ml	Kunststoffbeutel
1 x	3000 ml	Kunststoffbeutel
4 x	3000 ml	Kunststoffbeutel

Stoff- oder Indikationsgruppe oder Wirkungsweise
Lösung zur Zufuhr von Flüssigkeit und Elektrolyten

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

B. Braun Melsungen AG

Postfach 1

34212 Melsungen

Telefon: (0 56 61) 71-0

Telefax: (0 56 61) 71-45 67

Anwendungsgebiete

derlich.

Falls in einer Notsituation die Anwendung über eine Druckinfusion erfolgen soll, so ist unbedingt darauf zu achten, dass Behälter und Infusionssystem vor Anlegen der Infusion vollständig entlüftet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Beim Mischen mit anderen Arzneimitteln können physikalisch-chemische Unverträglichkeiten (Inkompatibilitäten) auftreten.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Zur intravenösen Infusion bzw. zum Spülen und Befeuchten.

Die Dosierung richtet sich nach dem Flüssigkeits- und Elektrolytbedarf.

Maximale Tagesdosis

Bis zu 40 ml/kg KG und Tag, entsprechend 6 mmol Natrium/kg KG und Tag.

Maximale Infusions- und Tropfgeschwindigkeit

Die maximale Infusionsgeschwindigkeit beträgt 5 ml/kg KG und Stunde. Die maximale Tropfgeschwindigkeit beträgt ca. 1,7 Tropfen/kg KG und Minute.

Die maximale Infusions- und Tropfgeschwindigkeit richtet sich nach dem klinischen Zustand des Patienten und sollte im Normalfall die angegebenen Werte nicht überschreiten.

Die zur Wundbehandlung bzw. zum Befeuchten erforderliche Menge richtet sich nach dem jeweiligen Bedarf.

Hinweise zur Druckinfusion in Notfallsituationen siehe Abschnitt "Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise", sowie Abbildungen am Ende dieser Packungsbeilage.

Anwendungsfehler und Überdosierung

Eine Überdosierung kann zu erhöhtem Natrium- und Chloridspiegel im Blut (Hypernatriämie, Hyperchlorämie), Überwässerung und erhöhtem Säuregehalt des Blutes (Acidose) führen.

Die Therapie besteht in Unterbrechung der Zufuhr (Infusionsstopp); Gabe von Arzneimitteln, die die Flüssigkeitsausscheidung über die Nieren steigern (Diuretika), unter ständiger Kontrolle des Elektrolythaushalts; Korrektur der Störungen des Flüssigkeits- und Elektrolythaushalts; evtl. Senkung des erhöhten Säuregehalts des Blutes (Acidose-therapie).

Nebenwirkungen

Bei der Anwendung kann es zu erhöhtem Natrium- und Chloridspiegel im Blut (Hypernatriämie und Hyperchlorämie) kommen.

Hinweis

Die Patienten werden aufgefordert, dem Arzt oder Apotheker jede Nebenwirkung mitzuteilen, die sie bei sich beobachten und die in dieser Packungsbeilage nicht aufgeführt ist.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit

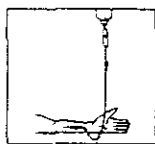
Nach Ablauf des angegebenen Verfalldatums nicht mehr anzuwenden!

Nur zu verwenden, wenn das Behältnis unverletzt und die Lösung klar ist.

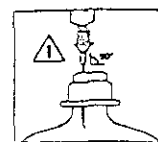
Handhabungshinweise Ecoflac® plus

1. Schwerkraftinfusion

- Belüftungsklappe und Rollenklemme am Infusionsgerät schließen
- Infusionsgerät einstecken, Tropfkammer ca. zur Hälfte füllen, Infusionsschlauch blasenfrei füllen
- Infusionsschlauch an Patienten anschließen
- Infusion bei geschlossener Belüftungsklappe starten

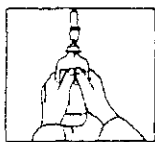


- ### 3. Zumischung von Arzneimitteln
- Arzneimittelzugabe mit einer Kanüle
- Kanüle senkrecht einstecken



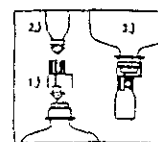
2. Druckinfusion

- Infusionsgerät einstecken
- Behälter aufrecht halten
- bei geöffneter Rollenklemme Luft vollständig aus dem Behälter entfernen und Tropfkammer ca. zur Hälfte füllen.
- Behälter um 180° drehen und Infusionsgerät entlüften
- Rollenklemme schließen

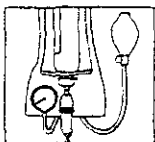


Arzneimittelzugabe mit Transferkappe (Ecoflac® Mix)

- 1.) Transferkappe auf Ecoflac® plus aufsetzen
- 2.) Vial am anderen Ende anschließen (klick)
- 3.) Flüssigkeit durch Druck auf Ecoflac® plus in Arzneimittel-Vial überführen. Arzneimittel vollständig auflösen. Anschließend um 180° drehen (Vial oben) und durch Druck auf Ecoflac® plus solange Luft in das Vial pressen, bis das Gesamtvolumen aus dem Vial überführt ist.

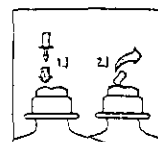


- Behälter in die Druckmanschette einlegen.
- Druck aufbauen
- Rollenklemme öffnen und Druckinfusion starten.



Markierung der Zugabe und Originalitätsverschluß mit Ecopin®

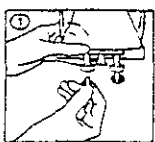
- 1.) Ecopin® in die Einstichstelle stechen
- 2.) Griffstück abbrehen



Handhabungshinweise Ecobag®

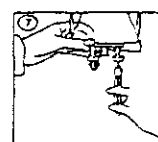
1.) Vorbereitung des Behälters

- Behälter und Verschuß auf Unversehrtheit prüfen.
- Inhalt auf Klarheit und Farbveränderungen kontrollieren.
- Behälter durch abdrehen des entsprechenden Knebels öffnen. Die freigelegte Einstichstelle ist steril.
- (☞ ⇒ Infusionsgerät)
- (☞ ⇒ Zumischen von Zusätzen)



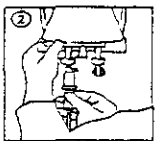
7.) Zumischen von Zusätzen mit der Spritze

- Zuspritzstelle durch abdrehen öffnen - Einstichstelle ist steril
- Medikament zuspritzen



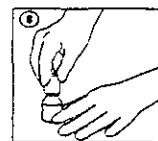
2.) Schwerkraftinfusion

- Belüftungsklappe und Rollenklemme am Infusionsgerät schließen
- Infusionsgerät einstecken



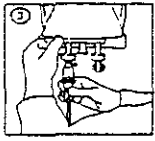
8.) Zumischen von Zusätzen mittels Transferset

- Medikamentenflasche öffnen und Einstichstelle desinfizieren
- Transferset aufsetzen und bis zum Anschlag einführen
- Bei Vakuumflaschen Transferset zuerst in den Beutel einführen



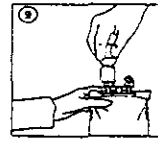
3.) Schwerkraftinfusion

- Tropfkammer ca. zur Hälfte füllen.
- Infusionsschlauch blasenfrei füllen.



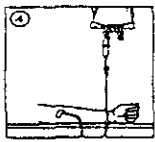
9.) Zumischen von Zusätzen mittels Transferset

- Zuspritzstelle durch abdrehen öffnen - Einstichstelle ist steril
- Transferset mit Flasche aufsetzen und bis Anschlag einführen



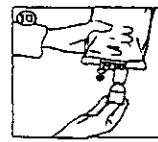
4.) Schwerkraftinfusion

- Infusionsschlauch an Patienten anschließen.
- Infusion bei geschlossener Belüftungsklappe starten.



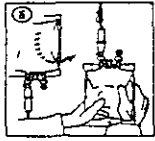
10.) Zumischen von Zusätzen mittels Transferset

- Lösung in die Medikamentenflasche pumpen
- Inhalt auflösen



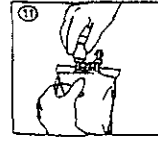
5.) Druckinfusion

- Infusionsgerät einstecken.
- Behälter aufrecht halten.
- Bei geöffneter Rollenklemme Luft vollständig aus dem Behälter entfernen und Tropfkammer ca. zur Hälfte füllen.
- Behälter um 180° drehen und Infusionsgerät entlüften.
- Rollenklemme schließen.



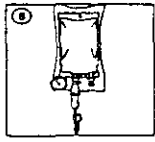
11.) Zumischen von Zusätzen mittels Transferset

- Beutel aufrecht drehen
- Luft in die Medikamentenflasche pumpen, die Lösung läuft in den Beutel
- Nach vollständiger Entleerung der Flasche Transferset mit Flasche abnehmen



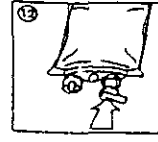
6.) Druckinfusion

- Behälter in die Druckmanschette einlegen.
- Druck aufbauen.
- Rollenklemme öffnen und Druckinfusion starten.



12.) Zumischen

- Zuspritzstelle mit der Memory Cap reversibel verschließen



B | BRAUN

B. Braun Melsungen AG
D-34209 Melsungen

User information

B. Braun Melsungen AG D-34209 Melsungen

S/12221686/0801
339106

Isotonic sodium chloride Solution 0,9% Braun

Composition

- medicinal active components

1000 ml infusion fluid contain:

Sodium chloride

9,0 g

- other Components

Water for injection

Theoretical osmolality

308 mOsm/l

Titration acidity (pH 7.4)

< 0,3 mmol/l

pH-Value

4,5 – 7,0

Electrolytes:

154

Sodium

154

Chloride

Presentation and Contents

Infusion fluid

1 x	100 ml	Glass bottle
10 x	100 ml	Glass bottles
20 x	100 ml	Glass bottles
1 x	250 ml	Glass bottle
10 x	250 ml	Glass bottles
1 x	500 ml	Glass bottle
10 x	500 ml	Glass bottles
1 x	1000 ml	Glass bottle
5 x	1000 ml	Glass bottles
1 x	100 ml	Plastic container
10 x	100 ml	Plastic container
20 x	100 ml	Plastic container
1 x	250 ml	Plastic container
10 x	250 ml	Plastic container
1 x	500 ml	Plastic container
10 x	500 ml	Plastic container
1 x	1000 ml	Plastic container
10 x	1000 ml	Plastic container

Set consisting of

1 x	500 ml	Plastic container, Infusion device and Venepuncture instruments
1 x	100 ml	Plastic bag
20 x	100 ml	Plastic bag
1 x	250 ml	Plastic bag
20 x	250 ml	Plastic bag

Contraindications

Isotonic sodium chloride solution 0,9% Braun should not be used for

- Overhydration (Hyperhydration syndrome)

Isotonic sodium chloride solution 0,9% Braun should be used with caution for

- low Potassium levels in the blood (Hypokalaemia)

- increased Sodium level in the blood (Hypernatraemia)

- increased Chloride level in the blood (Hyperchloraemia)

- Diseases, which call for a moderate Sodium supply, such as cardiac insufficiency, fluid accumulation in the tissue (generalized edema), fluid accumulation in the lung (Lung edema), high blood pressure (Hypertension), pregnancy-related diseases with high blood pressure, seizures and fluid accumulation in the tissue (Eclampsia), serious kidney dysfunctions (Kidney insufficiency)

Precautions and Warnings

A fast flowing infusion must be avoided for hypertonic dehydration conditions (cave: Rise of the Plasma osmolality and the Plasma sodium concentration) it is necessary to monitor the serum ionogram, the water balance, and the acid-base-status.

If an emergency situation calls for the administering via pressure infusion, it must be ensured that the container and the infusion system are fully ventilated prior to the infusion.

Interaction with other Medication

Physical-chemical incompatibilities can occur, when the solution is mixed with other medications.

Dosage, Type and duration of the application

For the intravenous infusion and for rinsing and moistening.

The dosage depends on the fluid- and electrolyte requirements.

Maximum daily dose

Up to 40 ml/kg KG and Day, corresponding to 6 mmol Sodium/kg KG and Day.

Maximum Infusion- and Dripping speed

The maximum Infusion speed is 5 ml/kg KG and Hour. The maximum Dripping speed is approx. 1,7 Drops/kg KG and Minute.

The maximum Infusion- and Dripping speed depends on the clinical condition of the patient and should under normal circumstances not exceed the indicated Values.

The quantity needed for the wound treatment and for moistening depends on the respective requirements.

For information regarding the pressure infusion in emergency situations, please refer to section "Precautions and Warnings" as well as to the

20 x	500 ml	Plastic bag
1 x	1000 ml	Plastic bag
10 x	1000 ml	Plastic bag

Application errors and Overdose

An overdose leads to an increased sodium- and chloride level in the blood (Hypernatraemia, Hyperchloraemia), overhydration and increased acid

Information regarding the dosage of the fluid- and electrolyte supply

30 ml per kg body weight and day only covers the basic physiological needs. This fluid dose must be increased, as part of the corrected basic need, to approx. 40 ml/kg body weight and day for post-operative patients and patients under intensive care, because of the reduced concentration power of the kidneys and the increase of metabolites, which must be discharged. Other forms of accompanying fluid losses (e.g. fever, diarrhoe, fistula, vomiting etc.) must be treated with an adjusted form of therapy.

The adjustment of currently and individually required fluid doses is always established by a necessary monitoring in stages (e.g. Urine discharge, Osmolarity in Serum and Urine, Determination of dischargeable substances).

The basic substitution of the most important Cations Sodium and Potassium is approx. 1,5 – 3,0 mmol/kg body weight and day, or 0,8 – 1,0 mmol/kg body weight and day respectively. The actual requirements as part of an infusion therapy depend on the respective preliminary evaluations and the laboratory checks of the plasma concentrations.

B | BRAUN



Handling instructions Ecoflac® plus

1. Gravity infusion

- Close the ventilation valve and the roller clamp on the Infusion device
- Pierce the Infusion device, fill approx. half of the drip compartment, avoid air bubbles when filling the Infusion tube
- Connect the Infusion tube to the patient
- Start the infusion with the ventilation valve closed



2. Pressure infusion

- Pierce the Infusion device
- Hold the container in vertical position
- Extract the air completely from the container with open roller clamps, and fill approx. half of the drip compartment.
- Turn the container 180° and ventilate the Infusion device
- Close the roller clamps



- Place container in the cuff
- Build up the pressure
- Open the roller clamp and start the pressure infusion



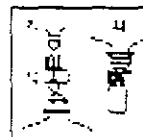
3. Drug admixture

- Drug admixture with a needle*
- Pierce in the needle vertically



Drug admixture with Transfer cap (Ecoflac® Mix)

- 1.) Place the Transfer cap onto the Ecoflac® plus
- 2.) Connect the vial on the other end (click on)
- 3.) Transfer the fluid into the Drug vial by applying pressure on the Ecoflac® plus. Dissolve the Drug completely. Turn by 180° (Vial on top) and press air into the vial by pressing on the Ecoflac® plus, until the entire fluid is transferred into the vial.



Marking the additive and original seal with Ecopin®

- 1.) Pierce Ecopin® into the puncture point
- 2.) Tear open the sealing tape



Handling instructions Ecobag®

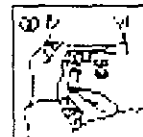
1.) Preparing the container

- Check the container and the seal for damages.
- Check the contents for clarity and discolorations.
- Open the container by unscrewing the toggle. The exposed puncture point is sterile.
- (U ⇒ Infusion device)
- (A ⇒ Drug admixture)



2.) Gravity infusion

- Close the ventilation valves and the roller clamp on the Infusion device
- Pierce the Infusion device



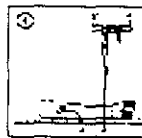
3.) Gravity infusion

- Fill approx. half of the Drip compartment.
- Fill the infusion tube without air bubbles.



4.) Gravity infusion

- Connect the infusion tube to the patient.
- Start the infusion with the ventilation valve closed.



5.) Pressure infusion

- Pierce the Infusion device.
- Hold the container upright.
- Extract the air fully from the container, with the roller clamp open, and fill approx. half of the drip compartment.
- Turn the container 180° and ventilate the Infusion device.
- Close the roller clamps.



6.) Pressure infusion

- Insert the container into the cuff
- Build up the pressure
- Open the roller clamps and start the pressure infusion.



7.) Admixing additives with the syringe

- Turn open the injection point – the puncture point is sterile
- Inject the drug



8.) Admixing additives with the Transfer set

- Open the medicine bottle and disinfect the puncture point
- Place the Transfer set on top and insert it until the stop
- For vacuum bottles, insert the Transfer set into the bag first



9.) Admixing additives with the Transfer set

- Turn open the injection point – the puncture point is sterile
- Place the Transfer set with bottle on top and insert it until the stop



10.) Admixing additives with the Transfer set

- Pump the fluid into the medicine bottle
- Dissolve the contents



11.) Admixing additives with the Transfer set

- Turn the bag into upright position
- Pump air into the medicine bottle, the fluid will flow into the bag
- Remove the Transfer set with bottle, when the bottle is completely empty



12.) Admixture

- Re-seal the injection point with the Memory Cap



B | BRAUN

B. Braun Melsungen AG
D-34209 Melsungen

